



疾病

神经性贪食症

作者: [Evelyn Attia](#), MD, Columbia University Medical Center;

[B. Timothy Walsh](#), MD, College of Physicians and Surgeons, Columbia University

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 8月 2025 | 修改的 1月 2026

神经性贪食症是一种**进食/饮食障碍**，其特征是反复快速地摄入大量食物（暴食），然后再对过度进食进行弥补（例如，清除食物、禁食或锻炼）。

- 患者进食大量食物，然后再通过使自己呕吐、服用泻药、节食、禁食或剧烈锻炼等方法来进行弥补。
- 当一个人过度关注自己的体重，且体重波动明显时，应高度怀疑本病。
- 认知-行为疗法，5-羟色胺再摄取抑制剂（一类抗抑郁药），或两者联用。

同**神经性厌食症**一样，神经性贪食症也受遗传和社会因素的影响。和神经性厌食症的另一个相似点是，神经性贪食症患者多为过于关注自己的体形和体重的年轻女性。贪食症多发于认为瘦是理想状态的文化中，也多发于参加强调体形或体重的活动（如体操、芭蕾舞）的人群中。

神经性贪食症主要发生于青少年和年轻成年人。大约每 200 名女性和每 1000 名男性中就有 1 人在一生中的某个阶段患有神经性贪食症。

神经性贪食症的症状

神经性贪食症患者有反复发作的暴食行为。也即，他们摄入大量食物，远远超出多数人在同等时间同等情形下所摄入的食物量。环境和文化很重要，因为平时用餐的过量标准与节假日用餐的过量标准可能不同。

精神紧张常会触发暴食行为，通常在私底下进行。暴食伴有失控感，通常包括不饥饿时进食以及吃到身体不适为止。

患者常进食高脂肪的甜食，如冰激凌和蛋糕。每次暴食的摄入量不尽相同，有时可达到上千卡路里。暴食发作频繁时可达每天数次。

您知道吗？

- 神经性贪食症患者常对自己的行为感到极度后悔或自责。
- 由于经常使用手指催吐，神经性贪食症患者的指节上可见瘢痕。

为了对抗过多食物带来的后果，患者常通过以下方式弥补：

- 清除——例如，使自己呕吐（自我催吐）或服用泻药或利尿剂（导致肾脏排泄更多水的药物）
- 严格控制进食或禁食
- 过度锻炼
- 以上任意组合

有些患者用利尿剂来治疗浮肿。

不同于神经性厌食症者，神经性贪食症患者的体重常在正常范围波动。神经性厌食症患者很少超重或肥胖。

不同于**暴食性障碍**，神经性贪食症患者尝试通过清除或其他方式来补偿过度饮食。

自我诱发呕吐会引起牙釉质腐蚀、使颊部唾液腺（腮腺）肿大和食管炎症。呕吐可能使血钾水平降低，导致心律失常。有报道多次服用大量催吐剂来诱发呕吐可引发心律失常、进而导致猝死。少数情况下，在暴食或清除期间，可能会发生胃破裂或食管撕裂，从而导致危及生命的并发症。

神经性贪食症患者过度关注自己的体重和体形，并根据自己的体重和体形来评判自己。他们的自尊在很大程度上取决于他们的体重和体形。

与神经性厌食症相比，神经性贪食症患者能意识到自己行为异常，并自觉懊悔和自罪。他们比厌食症者更有可能向医生或知己倾诉自己的问题。一般而言，神经性贪食症患者更外向。他们也更容易出现冲动行为、**药物或酒精使用障碍**以及**抑郁**。他们担心自己的体重，对参加社交活动充满焦虑。

神经性贪食症的诊断

- 医生根据标准精神病标准进行评估

当患者做以下行为，尤其是年轻女性时，医生会诊断神经性贪食症：

- 报告称每周暴食至少一次，至少持续 3 个月
- 暴食期间和之后感觉失控
- 通过清除（例如，使自己呕吐或使用泻药）、禁食或过度运动来补偿暴食
- 表达对体重增加的显著担忧，很大程度上基于体重和体形判断自我形象

医生还会检查其他支持神经性贪食症诊断的线索：

- 体重波动幅度大，尤其是如果有提示过度使用泻药的线索（如腹泻和腹部痉挛）
- 双颊唾液腺肿大

- 用手指自我催吐时造成的指关节划痕
- 胃酸造成的牙釉质腐蚀
- 血液化验显示低血钾

神经性贪食症的治疗

- 心理疗法（认知疗法或人际疗法）
- 某些抗抑郁药物

治疗神经性贪食症可采用认知行为疗法、人际心理治疗和药物治疗。

认知行为治疗是常用的治疗。治疗目标为

- 激励患者改变自己的行为
- 建立并维持正常灵活的进食方式
- 减少对体重和体形的关注

患者可与治疗师每周见面一两次，持续 4 至 5 个月，可采取一对一形式，也可采取小组治疗形式。认知行为疗法可帮助 30-50% 的暴食症患者消除暴食/清除行为。有些人会放弃治疗，有些人则毫无反应。那些出现改善的患者通常会保持改善。

人际心理治疗是认知行为治疗的一种替代治疗，可在后者无法提供时采取。它可以帮助患者找出和纠正导致其进食或饮食障碍的人际关系问题。该治疗并不告诉患者如何改变，也不诠释他们的行为，也不直接应对进食或饮食障碍。

选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂是一种抗抑郁药，可以减少暴食和呕吐的频率，最好与心理治疗联合使用。这些药物的长期效果尚不清楚。这些药物也可有效治疗神经性贪食症患者常出现的**焦虑**和**抑郁**症状。

了解更多信息

以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国进食障碍帮助协会 \(NEDA\)](#)

[美国国家神经性厌食症和相关疾病协会 \(ANAD\)](#)

[美国国立精神研究卫生研究所 \(NIMH\)，进食障碍](#)